

# Démarche scientifique de soins infirmiers

## Diapositive 1

DEMARCHE SCIENTIFIQUE DE SOINS INFIRMIERS

## **Diapositive 2**

### OBJECTIF GENERAL

Posséder une vue d'ensemble de la démarche scientifique ainsi que les objectifs qui sous-tendent son utilisation.

### **Diapositive 3**

#### **OBJECTIFS SPECIFIQUES**

Définir la démarche scientifique en soins infirmiers en général et celui de Virginia HENDERSON en particulier, selon le cours

Décrire toutes les étapes de la démarche de soins en précisant les étapes à partir desquelles apparaissent le diagnostic infirmier et le plan de soins.

Appliquer la démarche de soins en milieu clinique, communautaire ou dans tout autre domaine nécessitant une intervention infirmière, comme approche de résolution des problèmes des individus malades ou en santé ou de la collectivité

## **Diapositive 4**

### DEFINITION

Approche rationnelle, dynamique, composée de plusieurs étapes qui se succèdent selon un certain ordre et qui forme un tout logique.

Selon HENDERSON, c'est un processus intellectuel, dynamique, composé de diverses étapes logiquement ordonnées ayant pour but le mieux-être du client.

## **Diapositive 5**

Utilisée de façon rigoureuse, elle constitue une méthode systématique permettant de recueillir les informations nécessaires, de les traiter, de les concrétiser par des interventions adéquates et d'en évaluer les résultats.

## **Diapositive 6**

ETAPES DE LA DEMARCHE DE SOINS

Collecte des données

Analyse et l'interprétation des données recueillies

Planification des interventions

Exécution des interventions

Evaluation des interventions

## **Diapositive 7**

### COLLECTE DES DONNÉES

Elle consiste à recueillir tous les renseignements disponibles nécessaires au soin du client à partir de ses 14 besoins fondamentaux.

## **Diapositive 8**

### COLLECTE DES DONNÉES

Modes de collecte de données:

1 L'observation

L'entrevue

## **Diapositive 9**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Analyse :

Cette analyse s'opère par l'examen des données et leur classification en données d'indépendance pour celles qui traduisent une satisfaction autonome des besoins et en données de dépendance pour celle dont le client ne peut satisfaire autour des 14 besoins fondamentaux.

## **Diapositive 10**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

I

nterprétation

Interpréter signifie qu'on peut expliquer l'origine ou la cause du problème de dépendance du client et les facteurs qui y contribuent.

En résumé, l'analyse et l'interprétation des données est un processus mental en deux phases :

## **Diapositive 11**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Examiner

les faits observés, ensuite on fait les liens entre ces faits, les similitudes et les différences entre ces faits et les connaissances scientifiques ainsi que les explications scientifiques de ces faits ;

Poser

un jugement de valeur sur la signification de la situation analysée quant aux caractéristiques des compétences pouvant affecter la prise en charge.

## **Diapositive 12**

### **ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES**

L'analyse et l'interprétation en tant qu'étape de la démarche scientifique de soins aboutit au diagnostic infirmier

ou

diagnostic nursing

## **Diapositive 13**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Le diagnostic infirmier

est un énoncé qui décrit le problème de dépendance actuel ou potentiel du client regroupées ou non et reliées à une source de difficultés, et dont la résolution ne dépend que de l'infirmier (ère) ou de la sage-femme.

Il constitue le rôle autonome de l'infirmier(e) ou de la sage-femme

## **Diapositive 14**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Composantes d'un diagnostic infirmier

Le problème de dépendance

est un changement défavorable d'ordre biophysique, psychologique, social, culturel et spirituel dans la satisfaction d'un besoin fondamental et qui se manifeste par des signes observables

La source de difficulté

est un empêchement majeur à la satisfaction d'un ou de plusieurs besoins fondamentaux

## **Diapositive 15**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Exemple de diagnostics infirmiers

Douleurs thoraciques

dues à

la plaie chirurgicale (douleurs thoraciques = problème de dépendance, plaie chirurgicale = source de difficultés).

Difficultés respiratoires

reliées à

une obstruction des voies aériennes supérieures.

Risque potentiel d'accident

relié à

un déficit visuel.

## **Diapositive 16**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

On parle de

facteurs contributifs ou facteurs étiologiques secondaires

, lorsqu'il arrive parfois qu'une source de difficulté soit identifiée pour un problème, mais à l'analyse, on s'aperçoit que cet élément négatif n'agit pas seul et que d'autres facteurs entrent en jeu pour accentuer et compliquer l'influence de la source première.

## **Diapositive 17**

### ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

Exemple :

Difficultés à s'alimenter

reliées au

dégoût pour son régime alimentaire prescrit aggravées par les fortes émotions.

N.B

: les fortes émotions constituent le facteur constructif ou facteur étiologique secondaire.

## **Diapositive 18**

Différence entre un diagnostic médical et un diagnostic infirmier (nursing)

Diagnostic infirmier

Diagnostic médical

Orienté vers l'individu

Orienté vers la pathologie

Décrit la réaction de l'individu face au processus de la maladie

Décrit le processus de la pathologie

Orienté l'infirmier vers les activités autonomes ou guide ses actes infirmiers autonomes de soins infirmiers et l'évaluation

Orienté vers l'acte médical (parfois délégué à l'infirmier)

Ne possède pas une classification universelle acceptable

Complémentaire du diagnostic médical

Possède une classification universelle acceptable, bien développée

Complémentaire du diagnostic infirmier

## **Diapositive 19**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

La planification des interventions a deux composantes :

La fixation des objectifs de soins à court terme, à moyen terme et à long terme

La détermination des interventions infirmières.

## **Diapositive 20**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

La fixation des objectifs (1

er

volet de la planification)

L'objectif de soins

C'est la description d'un comportement observable que le soignant attend du client après la mise en œuvre des interventions infirmières. (Ce que le client doit être capable de faire de lui-même après les interventions infirmières).

## **Diapositive 21**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Caractéristiques d'un objectif de soins

Spécificité

é : c'est-à-dire appartenir à un seul sujet à la fois

Performance

: action ou comportement attendu de la personne

Implication

: le niveau d'engagement du client

## **Diapositive 22**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Caractéristiques d'un objectif de soins

Réalisme

: tenir compte des capacités (physiques, affectives, intellectuelles) de la personne

Observation

: l'objectif de soins doit être observable c'est-à-dire facile à repérer, à mesurer.

## **Diapositive 23**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Exemple de formulation d'un objectif de soins

Mme Kouakou doit être capable de manger les repas avec appétit dans 24 heures

Sujet

: Qui fait quoi ?

Mme Kouakou

Verbe d'action

: Quelle action doit poser le client ?

Manger

Conditions dans lesquelles se déroulent l'action

: Comment se fait l'action ? A

vec appétit

Indice d'évaluation

: Dans quelle mesure se fait l'action ?

Dans 24 heures

Exemple

: le client doit être capable de boire 1 500 ml d'eau / 24 H

Le client doit être capable de marcher avec aide, 3 fois par jour pendant 5 mn

## **Diapositive 24**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Détermination de l'intervention infirmière (deuxième volet de la planification)

Déterminer le type et le mode d'intervention à entreprendre pour susciter chez le client, le comportement attendu et corriger ses problèmes de dépendance.

Ces interventions sont des actes que l'infirmier (ou la sage-femme) doit poser lui-même ou déléguer aux autres.

## **Diapositive 25**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

Détermination de l'intervention infirmière (deuxième volet de la planification)

Ces interventions font partie des rôles de l'infirmier (ou la sage-femme) qui selon Virginia Henderson est le

rôle de suppléance.

Après la fixation des objectifs de soins et la détermination des interventions infirmières, on élabore un plan de soins

## **Diapositive 26**

### PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

#### L'exécution des interventions

Elle constitue le moyen de la réalisation du plan de soins. Ces interventions sont les actes que l'infirmier (ou la sage-femme) doit poser lui-même ou les déléguer aux autres. Ici les acteurs sont multiples. Il y a :

D'abord le client

Ensuite, l'infirmier

Les autres membres de l'équipe (équipe soignante) ;

Les membres de la famille

## **Diapositive 27**

### **EVALUATION DES SOINS**

Elle consiste à porter un jugement sur les interventions par le soignant lui-même. Quand l'objectif de soins est atteint, on observe chez le client un changement de comportement.

## **Diapositive 28**

PLAN DE SOINS

## **Diapositive 29**

### PLAN DE SOINS

Le plan de soins est un document écrit, établi par l'infirmier et qui comporte la liste de tous les soins requis par un client en réponse à ses besoins.

Ces soins sont repartis dans le temps (24H/exemple). Le P.S tient compte de la prescription médicale, des besoins prioritaires du client, des ressources disponibles, des caractéristiques propres, des particularités individuelles. Il n'est donc pas un document interchangeable parce que chaque individu étant

un tout complexe et différent

.

Il n'y a donc pas de modèle type de plan de soin à proposer pour tous les services.

## **Diapositive 30**

### PLAN DE SOINS

#### Avantage du plan de soins

Permet l'individualisation des soins : Identification des besoins prioritaires du client, apport des réponses aux besoins du client

Assure la continuité des soins : moyen de communication (écrite) entre infirmier et infirmier, entre infirmier et médecin, entre infirmier et parent de client

## **Diapositive 31**

### PLAN DE SOINS

Avantage du plan de soins•

Permet d'évaluer la qualité des soins : instrument de supervision des soins, suivre l'évolution de l'état du client

Instrument de formation (formation des étudiants, perfectionnement du personnel soignant)

## **Diapositive 32**

PLAN DE SOINS

Exemple de plan de soins

### **Diapositive 33**

LOGO DE LA STRUCTURE

NOM ...DELON..... PRENOM .....

Patrick.....

SEXE : /\_M\_\_\_\_\_/ AGE : /\_5ans\_\_\_\_/ PROVENANCE .....

Bingerville.....

SERVICE .....Pédiatrie..... N°CH : /

\_5\_\_\_\_/ N° LIT : /\_2\_\_\_\_/

N° DU DOSSIER CLIENT : /\_163X\_\_\_\_\_/ FEUILLE N° : /

DIAGNOSTIC MEDICAL : Paludisme grave

REGIME : Hospitalisé

Traitement :

Quinimax

0,40

Bencozyme

1 ampoule

Dans 250 ml de

Ringer

, en perfusion, 2 fois par jour pendant 3 jours

Novalgin

1 ampoule en IVD

Date/heure

Diagnostic infirmier/problèmes identifiés

Objectifs de soins

Interventions

Date/Heure

Résultats de l'évaluation

Nom Prénoms et émargement de l'intervenant

31/12/2019

23H59

- Hyperthermie reliée au paludisme

Retrouver sa T p normale (37 pc) au bout de 12 heures

Soins d'exécution des prescriptions médicales :

- Exécuter scrupuleusement le traitement prescrit
- Si nécessaire utiliser les moyens physiques pour lutter contre la fièvre

Soins de surveillance :

-Surveiller régulièrement les constantes notamment la T p

01/01/2020

11H58

T°37°5

KELLY Josiane